

專業治療

- 1. 骨水泥手術 | 椎體成形術與椎體撐開術
- 2. 微創腰椎手術 | 內視鏡/顯微減壓與固定融合
- 3. 微創頸椎手術 | 人工椎間盤置換與微創融合
- 4. 腕隧道神經鬆解術 | 正中神經減壓治療
- 5. 神經阻斷及疼痛介入治療 | 精準注射與疼痛控制
- 6. 骨質疏鬆與骨折風險治療 | 骨密度管理與藥物治療

微創頸椎手術 | 人工椎間盤置換與微創融合

透過前頸椎微創切口，精準解除神經壓迫；保留頸椎自然活動度，幫助您擺脫手麻、肩頸劇痛，重獲順暢生活。

當頸椎因為長期姿勢不良、退化、椎間盤突出或骨刺增生，壓迫到神經或脊髓時，常會引發肩頸痠痛、膏肓痛、手臂抽痛、手指麻木，甚至握力下降、手部動作變笨拙。

很多患者一聽到「頸椎要開刀」，第一反應都是害怕與抗拒。

擔心會不會癱瘓、脖子會不會變僵硬、以後是不是不能轉頭，因此一路忍痛拖延，直到手麻加重、肌力下降，甚至手部肌肉萎縮才就醫。

其實，現代前頸椎微創手術已是相當成熟的治療方式。

手術通常經由脖子前側自然皮膚皺摺，以小切口進入，順著解剖組織間隙抵達病灶，處理壓迫神經的椎間盤、骨刺或退化組織。

治療重點不是單純「把壓迫拿掉」，而是：

精準減壓、保護神經，並選擇最適合的椎間重建方式。

常見重建方式主要分為：

人工椎間盤置換手術 與 微創頸椎融合手術。

1. 人工椎間盤置換手術

Artificial Disc Replacement, ADR

人工椎間盤置換手術的概念是：

不只解除神經壓迫，更盡量保留頸椎原本的可動性。

人體原本的椎間盤，本來就不是固定不動的結構。
它除了維持椎間高度，也讓頸椎可以低頭、抬頭、轉頭與側彎。

人工椎間盤的設計，就是希望在清除壓迫神經的病灶後，透過可活動式人工椎間盤，盡量模擬原本椎間盤的活動功能。

對適合的患者來說，人工椎間盤置換是較符合人體原本功能構造的手術方式之一。

人工椎間盤置換的核心優點包括：

- 保留頸椎活動度：減壓後仍讓該節段保有較自然的活動
- 較接近原本椎間盤功能：兼顧椎間高度、支撐與活動能力
- 減少相鄰節段代償負擔：相較融合手術，可能降低上下節段長期承受過多壓力
- 生活適應較自然：對適合患者來說，術後活動感較接近原本頸椎狀態

適合情況包括：

- 單節或少數節段頸椎椎間盤突出
- 神經壓迫造成手麻、手痛、肩頸痛
- 頸椎原本活動度仍良好
- 沒有明顯頸椎不穩定
- 沒有嚴重關節退化、骨刺變形或椎間高度塌陷
- 希望在減壓後盡量保留頸椎自然活動度者

但人工椎間盤不是每一位患者都適合。

如果頸椎已經嚴重退化、關節硬化、骨刺廣泛增生、不穩定或變形明顯，融合手術可能反而是更安全、更穩定的選擇。

2. 微創頸椎融合手術

Anterior Cervical Discectomy and Fusion, ACDF

頸椎融合手術的概念是：

解除神經壓迫後，讓病灶節段穩定融合。

手術會清除壓迫神經的椎間盤、骨刺或退化組織，再置入椎間支架，必要時搭配固定，讓上下兩節骨頭隨時間融合成穩定結構。

融合手術的重點不是讓脖子「變僵硬」，而是在退化嚴重或不穩定的節段，重新建立穩定支撐，避免神經持續受到壓迫。

適合情況包括：

- 嚴重骨刺或椎間孔狹窄
- 頸椎不穩定或滑脫
- 椎間盤高度嚴重塌陷
- 關節退化明顯
- 多節頸椎退化合併神經壓迫
- 不適合人工椎間盤置換者

對部分患者來說，融合手術反而是更安全、更穩定的選擇。

人工椎間盤與融合手術快速比較

比較項目	人工椎間盤置換手術 ADR	微創頸椎融合手術 ACDF
治療概念	減壓後置入可活動式人工椎間盤	減壓後固定融合病灶節段
活動度	保留該節段較自然的低頭、抬頭與轉動	該節段不再活動，由上下節段代償
結構概念	較接近人體原本椎間盤活動功能	以穩定與減壓為主要目標
相鄰節段負擔	可能減少上下節段代償壓力	上下節段未來可能承受較多代償
術後活動感	較接近原本頸椎活動方式	需要適應融合後的活動變化
適合對象	活動度仍好、退化不嚴重、無明顯不穩者	嚴重骨刺、關節退化、不穩定或變形者
治療重點	減壓後保留功能	減壓後重建穩定

簡單來說：

人工椎間盤，是解除壓迫後，盡量保留原本活動功能。

融合手術，是解除壓迫後，讓不穩定或退化嚴重的節段重新穩定。

所以，並不是人工椎間盤一定比較好，也不是融合手術一定不好。

真正重要的是：您的頸椎條件，適合哪一種方式。

人工椎間盤與融合支架都要自費嗎？

不一定。

頸椎手術使用的人工椎間盤、椎間支架或相關植入物，部分在符合健保規範與病況條件時，可以評估申請健保給付。

也就是說，並不是一聽到「人工椎間盤」或「融合支架」就一定全部都要自費。

除了健保給付的醫材外，也有特殊材質、特殊設計或功能較進階的自費與差額負擔醫材可以選擇。

簡單來說：

健保醫材，是在符合條件下提供基本且有效的治療需求。

自費或差額負擔醫材，則可能在材質、設計、活動表現、骨整合能力、影像相容性或長期穩定性上有更進階的選擇。

以人工椎間盤來說，不同產品在活動軸心、材質耐磨性、穩定設計、活動角度與生體相容性上可能有所不同。

較進階的人工椎間盤，通常希望更接近人體原本椎間盤的活動方式，兼顧支撐高度、活動度與長期穩定。

以融合支架來說，自費或差額負擔的特殊材質支架，可能具備較好的骨整合設計、較佳的影像判讀相容性，或有助於維持椎間高度與融合穩定。

不過，自費不代表一定比較適合每一位患者。

真正重要的是：自費醫材的優點，是否真的對您的病況有幫助。

在門診中，醫師會依照神經壓迫位置、頸椎活動度、退化程度、骨質條件與生活需求，說明健保與自費醫材的差異，協助您選擇最合理的治療方式。

什麼情況不能再拖？

如果只是肩頸痠痛或手麻，通常可以先安排門診評估。

但如果已經出現以下情況，代表神經或脊髓可能受到較嚴重壓迫，應儘快就醫：

- 手麻越來越嚴重
- 手臂無力、握力下降
- 拿筷子、扣鈕扣、寫字變笨拙
- 手掌虎口凹陷或肌肉萎縮
- 走路不穩，像踩在棉花上

- 雙手雙腳都出現麻木或無力
- 大小便控制異常

如果頸椎脊髓已經嚴重受壓，跌倒、車禍或外力撞擊後，可能造成更嚴重的神經損傷。若出現明顯四肢無力、無法行走或大小便異常，應立即就醫，必要時直接到急診評估。

文宏裕醫師的治療觀點

很多患者因為害怕頸椎開刀會變得像「木頭人」一樣不能轉頭，所以一路忍痛拖延，直到手麻加重、肌力下降，甚至影響走路才就醫。

其實，頸椎手術不是只有融合固定一種選擇。

如果頸椎活動度仍良好、退化不嚴重，且病灶條件適合，人工椎間盤置換可以在解除神經壓迫後，保留較接近原本椎間盤的活動功能。

但如果頸椎已經不穩定、骨刺嚴重或關節退化明顯，融合手術可能反而是更安全、更穩定的選擇。

能保留活動度的，我們盡量保留；
需要穩固融合的，我們精準做好支撐。

如果手麻、肩頸痛、手臂無力或走路不穩已經影響生活，就不要只是一直忍耐。
讓專業醫師協助您判斷，才能選擇最適合的治療方式。

不該開的刀，我不開；該開的刀，我做到最好。

手術不是目的，重新回到生活才是目的。

把時間留給生活，不留給疼痛。